clube do plantonista

checklist do plantão seguro

Salva no celular e confere antes de cada plantão.



1 ANTES DE SAIR DE CASA

- [ ] **Estetoscópio**
- [ ] **Oxímetro de pulso** (com bateria)
- [ ] **Caneta** (leve duas: uma sempre some)
- [ ] **Jaleco**
- [ ] **Celular carregado** + carregador ou bateria externa
- [ ] **Fone de ouvido**
- [ ] **Carimbo** e documento com o CRM

Na véspera: confira a escala, o endereço e quem você rende.

2 NO INÍCIO DO PLANTÃO

- [ ] **Passagem de plantão feita direito.** Paciente por paciente: diagnóstico, quão grave está, o que está pendente (exame, parecer, reavaliação) e o que fazer se piorar. Os graves primeiro.
- [ ] **Material de emergência checado.** Laringoscópio com luz e lâminas 3 e 4 · tubos 7,0 a 8,0 e bougie · ambu ligado ao O_2 · aspirador ligado e funcionando · desfibrilador carregado, com pás ou eletrodos · monitor e oxímetro.
- [ ] **Saber onde está o carrinho de PCR.** E se está lacrado e conferido: adrenalina, amiodarona, atropina, material de via aérea.
- [ ] **Saber quem é o plantonista de suporte** e como falar com ele agora, não na hora do aperto.

Suporte de hoje	_____	**ramal**	_____
Cardio / hemodinâmica	_____	**ramal**	_____
UTI / regulação de vaga	_____	**ramal**	_____

3 NO BOLSO OU SALVO NO CELULAR

PLANO-SEQUÊNCIA DO ECG

1. **Contexto do paciente**: idade, queixa, por que pediram o ECG
2. **Exame bem feito?** 25 mm/s · 10 mm/mV · D1 positivo e aVR negativo
3. **Ritmo**: sinusal? P positiva em D1, D2 e aVF
4. **Frequência**: QRS no D2 longo × 6 (normal 50–100)
5. **Regularidade**: RR igual? Irregular sem P = FA até prova em contrário
6. **Eixo**: D1 e aVF (na dúvida, D2 desempata)
7. **Ondas**: P, QRS e T
8. **Intervalos**: PR, QRS e QT
9. **Segmentos**: ST, supra ou infra

DOSES DA INTUBAÇÃO · por kg de peso

Fentanil	**1–3 mcg/kg**	3 min antes (pré-tratamento)
Etomidato	**0,3 mg/kg**	indutor padrão, estável no choque
Cetamina	**1–2 mg/kg**	ideal no broncoespasmo
Propofol	**1–2 mg/kg**	só no estável
Succinilcolina	**1,5 mg/kg**	não em hipercalemia
Rocurônio	**1,2 mg/kg**	reversão: sugamadex 16 mg/kg

DROGAS VASOATIVAS · O ESSENCIAL

Noradrenalina	4 amp (16 mL) + 234 mL SG 5% = **64 mcg/mL** · início 0,05 mcg/kg/min · meta PAM ≥ 65
Dobutamina	4 amp (80 mL) + 170 mL SG 5% = **4 mg/mL** · 5–20 mcg/kg/min
Dopamina	5 amp (50 mL) + 200 mL SF = **1 mg/mL** · 5–15 mcg/kg/min (bradi)
Vasopressina	1 amp + 99 mL = **0,2 UI/mL** · 0,01–0,04 UI/min (UI/min × 300 = mL/h)

Doses completas, diluições e tabelas por peso nos outros materiais do Kit. Para a conta na hora (mL/h × peso), o app **Dose Certa**.

QUANDO ACIONAR O CÓDIGO

DOR TORÁCICA	ECG em até **10 MIN** da chegada. Supra de ST: aciona a hemodinâmica; sem angioplastia em até 120 min, trombólise com porta-agulha ≤ 30 min.
AVC	Déficit neurológico súbito: código AVC, glicemia capilar e TC sem contraste. Trombólise até **4,5 H** do último momento visto bem; trombectomia até 24 h em selecionados.
SEPSE	Suspeita de infecção + hipotensão, rebaixamento, dessaturação ou lactato alto: pacote da **1ª HORA** (lactato, hemoculturas, antibiótico; volume se hipotenso ou lactato ≥ 4).
PCR	Não responde e não respira normalmente: chama ajuda, começa a RCP, pede o desfibrilador. Pulso: no máximo **10 S** para checar.